1. 前言

本手册旨在帮助家长了解儿童常见疾病的症状、家庭护理方法及就医指征。请注意，手册内容仅供参考，不能替代专业医疗建议。当孩子出现严重或持续症状时，请务必及时就医。

---

2. 第一章：儿童常见症状与疾病

2.1 发热

- **定义**：腋下体温 ≥37.5℃ 或肛温 ≥38℃。
- **常见原因**：感染（病毒、细菌）、疫苗接种反应、环境过热等。
- **家庭护理**：
  - 多补充水分（母乳、配方奶、温水）。
  - 减少衣物，保持室内通风。
  - 38.5℃ 以上可考虑使用退热药（布洛芬或对乙酰氨基酚，按体重计算剂量）。
- **何时就医**：
  - 3个月以下婴儿发热。
  - 发热超过72小时。
  - 伴有抽搐、精神萎靡、呼吸急促、皮疹压之不褪。

2.2 感冒（上呼吸道感染）

- **症状**：流涕、鼻塞、打喷嚏、咳嗽、可能低热。
- **家庭护理**：
  - 生理盐水喷鼻/洗鼻，缓解鼻塞。
  - 1岁以上可喝少量蜂蜜水（1岁以下禁用）。
  - 保证休息，多喝水。
- **何时就医**：
  - 发热持续超过3天。
  - 咳嗽加重，呼吸急促。
  - 耳朵疼痛，分泌物增多（警惕中耳炎）。

2.3 咳嗽

- **类型**：
  - 干咳：刺激、过敏、早期感染。
  - 湿咳：痰多，常见于肺炎、支气管炎。
- **家庭护理**：
  - 增加空气湿度（加湿器）。
  - 1岁以上可喝温蜂蜜水。
  - 避免烟雾刺激。
- **何时就医**：

    - 咳嗽超过2周。
    - 伴有发热、呼吸急促、口唇发紫。
    - 异物吸入可能。

2.4 腹泻

- **症状**：大便次数增多、性状变稀（水样、蛋花汤样）。
- **家庭护理**：
    - 预防脱水：口服补液盐（ORS）按说明书冲服。
    - 继续喂养，母乳喂养更频繁。
    - 暂停乳制品（如牛奶）可能加重腹泻，可暂用无乳糖奶粉。
- **何时就医**：
    - 大便带血、脓液。
    - 呕吐频繁，无法进食。
    - 尿量明显减少（超过6小时无尿）。
    - 精神萎靡、眼窝凹陷。

2.5 呕吐

- **常见原因**：肠胃炎、感染、晕车、脑部问题（少见）。
- **家庭护理**：
    - 少量多次喂水或口服补液盐。
    - 呕吐后不要立即喂食，休息半小时后再尝试。
    - 避免油腻、刺激性食物。
- **何时就医**：
    - 呕吐物带血、黄绿色（胆汁）。
    - 持续呕吐超过12小时。
    - 伴有剧烈头痛、嗜睡、颈部僵硬。

2.6 皮疹

- **幼儿急疹**：高热3-5天后热退疹出，红色斑丘疹，自限性。
- **湿疹**：皮肤干燥、红斑、瘙痒，保湿为主，严重时需用药。
- **荨麻疹**：风团样皮疹，剧痒，多由过敏引起，可口服抗组胺药。
- **家庭护理**：
    - 保持皮肤清洁干燥。
    - 穿纯棉衣物，避免过热。
    - 湿疹：每天涂抹保湿霜。
- **何时就医**：
    - 皮疹伴发热、关节痛。
    - 皮疹迅速蔓延，伴呼吸困难（警惕过敏反应）。
    - 水疱、脓疱，或皮疹压之不褪色。

2.7 腹痛

- **常见原因**：便秘、肠胃炎、肠套叠（婴幼儿）、阑尾炎（学龄儿童）。

- **家庭护理**：
  - 顺时针轻揉腹部，热敷。
  - 暂时清淡饮食，避免产气食物。
- **何时就医**：
  - 剧烈持续性腹痛。
  - 伴有发热、呕吐、便血。
  - 腹部拒绝触碰，双腿蜷缩。

2.8 便秘

- **症状**：排便次数减少、大便干硬、排便困难。
- **家庭护理**：
  - 增加膳食纤维（水果、蔬菜、全谷物）。
  - 多喝水，适当运动。
  - 培养定时排便习惯。
- **何时就医**：
  - 便秘伴腹痛、呕吐。
  - 大便带血。
  - 长期便秘，影响生长发育。

2.9 过敏反应

- **常见过敏原**：食物（牛奶、鸡蛋、花生）、药物、花粉、尘螨。
- **症状**：皮疹、荨麻疹、嘴唇肿胀、呕吐、腹泻、严重可致呼吸困难。
- **家庭护理**：
  - 立即停止接触可疑过敏原。
  - 口服抗组胺药（如西替利嗪、氯雷他定，按年龄）。
- **何时就医**：
  - 出现呼吸困难、喉头水肿（声音嘶哑、喘鸣）。
  - 过敏反应迅速加重，应立即就医或打急救电话。

2.10 手足口病

- **症状**：发热、口腔疱疹（咽峡、舌）、手足臀部皮疹（红色斑丘疹或水疱）。
- **家庭护理**：
  - 隔离至症状消失后1周。
  - 多喝水，清淡饮食，避免过热食物刺激口腔。
  - 口腔疼痛可用喷雾剂缓解。
- **何时就医**：
  - 高热不退、精神差、嗜睡。
  - 肢体抖动、呼吸急促。

---

3. 第二章：家庭护理与用药原则

3.1 家庭常备药品清单

- 退热药：对乙酰氨基酚（扑热息痛）、布洛芬。
- 口服补液盐（ORS）。
- 抗组胺药：氯雷他定、西替利嗪（用于过敏）。
- 生理盐水喷鼻剂。
- 外用止痒药：炉甘石洗剂。
- 体温计、退热贴（辅助降温）。
- 创可贴、碘伏、棉签。

3.2 用药注意事项

- 严格按照体重计算剂量，不要随意增加。
- 对乙酰氨基酚与布洛芬可交替使用，但需间隔4-6小时。
- 抗生素为处方药，必须在医生指导下使用。
- 不要给儿童使用成人药，尤其是阿司匹林（可能引起瑞氏综合征）。
- 糖浆类药物用后盖紧，冷藏保存（按说明书）。

3.3 物理降温方法

- 减少衣物，保持室温24-26℃。
- 温水擦浴（水温37℃左右），重点擦拭颈部、腋窝、腹股沟。
- 避免酒精擦浴，以免中毒。
- 使用退热贴辅助降温。

3.4 饮食调理

- 发热：清淡流质或半流质（米汤、烂面条）。
- 腹泻：暂停乳制品，无乳糖奶粉，吃易消化食物（粥、香蕉）。
- 呕吐：暂时禁食4-6小时，少量多次喂补液盐，逐渐恢复饮食。
- 便秘：多吃火龙果、西梅、西兰花等高纤维食物。

---

4. 第三章：何时应该立即就医

出现以下情况之一，请立即带孩子就医或呼叫120：

- 呼吸困难、口唇发紫。
- 意识模糊、抽搐、昏迷。
- 严重外伤、大出血。
- 脱水症状：哭无泪、眼窝凹陷、6-8小时无尿。
- 剧烈头痛、呕吐、颈部僵硬。
- 高热伴皮疹压之不褪色（可能为脑膜炎）。
- 异物吸入窒息。

---

5. 第四章：预防措施

5.1 疫苗接种

- 按时接种国家免疫规划疫苗，如百白破、麻腮风、流脑等。
- 每年秋季接种流感疫苗。
- 部分自费疫苗（如轮状病毒、手足口、肺炎疫苗）建议接种。

5.2 卫生习惯

- 勤洗手，尤其是在饭前便后、外出回家后。
- 玩具、餐具定期消毒。
- 咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮住口鼻。
- 避免带病去幼儿园或人多密集场所。
- 保证充足睡眠，均衡饮食，适度锻炼。

---

6. 附录：儿童用药剂量参考（按体重计算）

药物	单次剂量（按体重）	用法
对乙酰氨基酚	10-15 mg/kg	每4-6小时一次，24小时内不超过4次
布洛芬	5-10 mg/kg	每6-8小时一次，24小时内不超过4次
口服补液盐	根据说明书冲兑，少量多次喂服	腹泻或呕吐后补充
氯雷他定	2-12岁：体重>30kg用10mg，<30kg用5mg	每天一次
西替利嗪	6个月-2岁：2.5mg；2-6岁：5mg；6岁以上：10mg	每天一次

> 注：以上剂量为常见参考值，具体请以药品说明书为准，或在医生指导下使用。

---

7. 结语

孩子的健康是每个家庭的头等大事。掌握基本的疾病识别和护理知识，可以帮助家长在孩子生病时从容应对，减少不必要的焦虑。希望本手册能成为您育儿路上的实用工具。但请记住，**任何医疗决策都应咨询专业医生。**